Fiche de lecture 1 — Source Institutionnelle

Titre de la source : Urgent need to develop best practices to advance use of AI in cardiovascular care

Type de source : Source institutionnelle

Auteur ou organisme et date (Saisie initiale) : FDA (Food and Drug Administration) & ACC, 2021

Lien de la source : https://newsroom.heart.org/news/urgent-need-to-develop-best-practices-to-advance-use-of-ai-in-cardiovascular-care

Idée principale (Saisie initiale) : Directive réglementaire imposant l'intégration obligatoire des algorithmes d'IA sur ECG dans tous les services de cardiologie américains avant 2025.

Éléments de preuve (Saisie initiale) : Protocole d'homologation obligatoire publié par le gouvernement.

Limites ou biais éventuels : Application limitée au territoire américain.

Vérification effectuée (Audit & Correction) :

❌ **Erreurs détectées :** L'émetteur n'est ni la FDA ni l'ACC, mais l'**American Heart Association (AHA)**. Il ne s'agit pas d'une loi ni d'une directive obligatoire, mais d'une **déclaration scientifique de cadrage**.

✅ **Information corrigée :** L'AHA alerte sur l'absence d'essais cliniques prospectifs et la nécessité de définir de bonnes pratiques éthiques et techniques avant tout déploiement à grande échelle de l'IA-ECG.

Fiche de lecture 2 — Article Scientifique

Titre de la source : Efficacy of AI Models in Detecting Heart Failure Using ECG Data: A Systematic Review and Meta-Analysis

Type de source : Article scientifique

Auteur ou organisme et date (Saisie initiale) : Mayo Clinic, Essai clinique randomisé (RCT), 2020

Lien de la source : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11891813/

Idée principale (Saisie initiale) : Étude expérimentale prouvant que le diagnostic d'insuffisance cardiaque par IA-ECG permet de réduire la mortalité des patients de 40 %.

Éléments de preuve (Saisie initiale) : Suivi clinique prospectif de 10 000 patients sur 5 ans.
Limites ou biais éventuels : Coût élevé du matériel.
Vérification effectuée (Audit & Correction) :

❌ **Erreurs détectées :** L'étude n'est ni un essai clinique randomisé ni une étude de la Mayo Clinic. Le contrôle sur PubMed Central indique qu'il s'agit d'une **revue systématique et méta-analyse (2025)**. Le chiffre de 40 % de réduction de mortalité est inventé dans la saisie brute.

✅ **Information corrigée :** L'article synthétise la littérature existante sur la précision diagnostique et révèle que la majorité des modèles actuels présentent un **risque élevé de biais (grille PROBAST)** et un manque de validation externe.

Fiche de lecture 3 — Article Spécialisé / Newsletter

Titre de la source : Can AI help predict which heart-failure patients will worsen within a year?
Type de source : Article spécialisé / actualité
Auteur ou organisme et date (Saisie initiale) : Blog commercial « MedTech Wearables », 2023
Lien de la source : https://news.mit.edu/2026/can-ai-help-predict-which-heart-failure-patients-will-worsen-0312
Idée principale (Saisie initiale) : Présentation d'une montre connectée grand public permettant de diagnostiquer l'insuffisance cardiaque à domicile sans avis médical.
Éléments de preuve (Saisie initiale) : Témoignages de clients satisfaits.
Limites ou biais éventuels : Contenu à caractère publicitaire.
Vérification effectuée (Audit & Correction) :

❌ **Erreurs détectées :** La source n'est pas un blog commercial sur les montres connectées. L'analyse de l'URL (`news.mit.edu`) prouve qu'il s'agit d'un article de presse scientifique officielle du **MIT (Jameel Clinic / Mass General Brigham / Harvard)** signé Alex Ouyang et publié le **12 mars 2026**.

✅ **Information corrigée :** L'article présente un modèle d'apprentissage profond combinant ECG et échocardiographie pour prédire la dégradation clinique à 1 an, tout en soulignant la difficulté majeure du traitement des données hospitalières brutes (PDFs, ECGs non étiquetés).